

MONOARTRITIS

Ismael González Fernández, Alejandra López Robles, Julio Tito Camino Acha.

INTRODUCCIÓN

La monoartritis es una sinovitis inflamatoria aguda o crónica que afecta a una sola articulación. Puede producirse en cualquier localización articular, sin embargo, suele ser más frecuente en grandes articulaciones como hombros, caderas, rodillas y tobillos. Se puede objetivar calor, rubor, tumefacción y dolor articular, pudiendo coexistir con fiebre.

- ¡¡ SIEMPRE que sea posible realizar artrocentesis ante toda monoartritis !!

DIAGNÓSTICO

Clasificación según duración

- **Aguda: (<6 semanas)** presentación brusca que evoluciona en horas o pocos días con una inflamación muy intensa.
- **Subaguda:** presentación no explosiva con evolución a la cronicidad.
- **Crónica: (>6 semanas)** duración de más 6 semanas.

Anamnesis

Preguntar por antecedentes familiares, de inmunosupresión, de viajes a zonas endémicas, características del dolor, localización y sintomatología sistémica.

Exploración física

- Movilidad articular: Si hay limitación en la movilidad suele ser por artritis; si por el contrario, la movilidad está conservada debemos descartar que el origen del dolor y de la inflamación se encuentra en estructuras vecinas como tendones, ligamentos o bolsas serosas.
- Examen cutáneo: Tumefacción, eritema local (típico de afectación de articulaciones superficiales), lesiones en mucosa oral-genital (Beçhet), vesículas/pústulas cutáneas (artritis gonocócica).
- Exploración sistémica.

Pruebas complementarias

- Hemograma con formula y recuento leucocitario.
- Bioquímica: glucosa, urea, creatinina, sodio, potasio, cloro, ácido úrico, GOT, GPT, GGT, amilasa, reactantes de fase aguda y signos de infección (PCR, VSG, procalcitonina). Ante sospecha de artritis reactiva solicitar serologías (Campylobacter, Shigella, Salmonella)
- Sistemático y sedimento de orina. Para descartar foco febril.
- Hemocultivos por dos si signos de infección o fiebre.
- Rx de la articulación afectada y la contralateral para comparación y seguimiento. La radiología simple de la articulación en estudio no sirva para poder detectar cambios degenerativos (osteofitos, disminución del espacio articular, esclerosis subcondral), condrocalcinosis.
- Otras pruebas: ecografía (sobre todo para valorar partes blandas y guiar punciones), TAC, RMN, gammagrafía ósea regional, estas pruebas tienen valor en el estudio tanto de la patología articular infecciosa como del diagnóstico diferencial pero por su poca disponibilidad en urgencias deberá ser solicitadas de forma programada.
- **Artrocentesis:** ante toda monoartritis hemos de realizar punción siempre que el derrame

articular sea significativo y no este **contraindicado**: celulitis en el área de punción, placa de psoriasis, trastornos de la coagulación (pacientes con anticoagulación oral con warfarina o acenocumarol no contraindica la artrocentesis si el INR este en rango terapéutico).

El **estudio y cultivo del líquido sinovial** comprenderá:

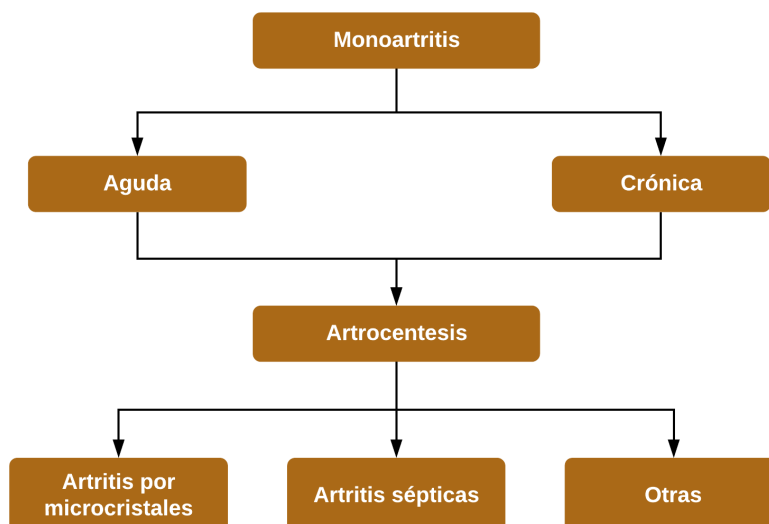
- Valoración del aspecto macroscópico y viscosidad.
- Estudio bioquímico.
- Recuento con fórmula leucocitaria.
- Búsqueda de cristales con luz polarizada, siendo los mas comunes: cristales de urato monosódico y cristales de pirofosfato cálcico dihidratado y la tinción con Rojo Alizarina, se visualizan cristales de hidroxapatita (son de pequeño tamaño y ausencia de birrefringencia) no visibles al microscopio óptico. Se solicita principalmente ante artropatía destructiva de hombro o bursitis acromio-subdeltoidea recurrente.
- Si líquido muy inflamatorio Tinción de Gram urgente.
- **Examen citoquímico** (2 tubos estériles, 1 con heparina) se solicitara recuento celular, glucosa, proteínas, cristales y ADA si procede.
- **Microbiología** (1 tubo estéril y 2 tubos/frascos de hemocultivos) solicitaremos examen: Tinción de Gram urgente, cultivo general y cultivo de microbacterias.
- **Cultivo del líquido sinovial**: se considera "Ante toda monoartritis aguda debe de ser considerada infecciosa hasta no demostrar lo contrario: presencia de cristales y cultivo sinovial negativo".

Características del líquido sinovial

	N	NI	I	S	H
Viscosidad	Alta	Alta	Baja	Variable	Baja
Aspecto	Trasparente	Amarillo claro	Amarillo pajizo	Purulento	Sanguino-lento
Leucocitos	50-200	200-2.000	2.000-50.000	^{>} 50.000	Variable
PMN	^{<} 10%	^{<} 10 %	Variable	^{>} 90%	-
Glucosa (mg/ml)	80-100	95-100	80-100	50	Variable
Proteínas (g/dl)	1,3-1,8	3-3,5	^{>} 4	^{>} 4	Variable
Ejemplos		Artrosis Necrosis aséptica	AM AR Esp. Autoinm.	Artritis séptica	Hemofilia Depósito pirofosfato

N: Normal. NI: No inflamatoria. I: Inflamatoria. S: Séptico. H: Hemorrágico. AM: Artritis por microcristales. AR: Artritis reumatoide. Esp: Espondiloartropatías.

Algoritmo diagnóstico



Artritis por microcristales: la más frecuente. Clínicamente indistinguibles entre ellas; el análisis del líquido sinovial permite su diferenciación. Suele afectar a articulaciones de miembros inferiores, sobre todo en la gota y condrocalcinosis. **Ver capítulo artritis por microcristales.**

Artritis séptica: primera a considerar por gravedad (compromiso vital). Brusca, muy dolorosa, con fiebre y escalofríos. Relación con infecciones previas (cutánea, urinaria, respiratoria...) y con factores de riesgo (DM, corticoides, manipulación articular...). Valorar puerta de entrada. Suele afectar a grandes articulaciones. **Ver capítulo artritis séptica.**

Criterios De Ingreso

- Artritis séptica.
- Sospecha de enfermedad sistémica con afectación del estado general.

TRATAMIENTO

El tratamiento antibiótico empírico endovenoso se basará en la tinción de Gram y antecedentes epidemiológicos del paciente.

Drenaje de las grandes articulaciones, se tomara muestra y aliviar la clínica al disminuir la presión articular. No realizar infiltración local con glucocorticoides hasta no descartar origen infeccioso.

Inmovilización inicial y rehabilitación.

El tratamiento habitual será de 4 semanas, puede variar en función del germen aislado y evolución clínica. La duración según germen aislado:

- 2 semanas: H. influenzae, estreptococos y gonococo.
- 4 semanas si existe osteítis: S. aureus y bacilos Gram negativos.

Artritis por microcristales: Evitar diuréticos, aspirina y alcohol. Usaremos AINES, colchicina, corticoides y si procede infiltración.

- **AINES** (diclofenaco 50 mg 1 c/8 h, indometacina (inacid) 25 mg c/8 h, naproxeno 550mg 1 c/12h) usar un HBP tipo pantoprazol 20mg c/12h o 40mg c/24h.
- **Colchicina** en dosis de 0,5 a 1 mg c/24h: Colchimax 0,5 mg capsulas o Colchicina Houde 1 mg capsula, se usa como profilaxis de nuevos episodios, no como tratamiento agudo.

- **Corticoides:** tipo prednisona (Dacortin) 30mg pauta descendente durante 10-15 días. Si refractariedad o contraindicación a AINEs.
- **Infiltración local:** Se podría plantear la necesidad de infiltraciones locales si se descarta artritis séptica y fracaso de tratamiento.

Artritis gotosa: Mismo tratamiento, pero evitar suprimir tratamiento de base y no instaurar tratamiento hipouricemiante hasta no haber pasado aprox 15 días, luego iniciar Alopurinol 100mg c/24h incrementar dosis progresivamente hasta alcanzar 300mg 1c/24h hasta obtener objetivo: ácido úrico menos 6mg/dl.

Artritis séptica: ver capítulo específico.

Hospitalización del paciente. Inicio del tratamiento empírico en función de la edad y probabilidad del germen más habitual. Drenaje e inmovilización de la articulación.

TRATAMIENTO ESPECIFICO SEGÚN TINCIÓN GRAM

Resultado de tinción de Gram del líquido articular	Antibiótico de elección
Cocos Gram -	• ceftriaxona 2gr / 24h IV. En menores de 6 años cefuroxima: 30 a 100mg/kg/día. En inmunocomprometidos añadir aminoglucósidos: tobramicina o gentamicina o amikacina. • Si alergia: ciprofloxacino 400mg c/12h IV.
Cocos Gram +	• Cloxacilina 2 gr c/ 4h IV.
Bacilos Gram -	• Ceftazidina 1 gr c/8h • Si alergia: ciprofloxacino 400mg c/12h + gentamicina 3-5mg/kg/24h IV en los primeros 3-5 días o Aztreonam 2 gr c/8h.
No se aísla microorganismos o no se realiza tinción gram	• cloxacilina 2gr c/4h IV + Ceftriaxona 2 gr c/24h IV. • Si alergia: vancomicina 15mg/kg/12h + Ciprofloxacino 400mg c/12h IV.
Infección sobre prótesis articular	ciprofloxacino 400mg c/12h IV. y vancomicina 15mg/kg/12h.
Artritis brucelar	doxiciclina durante 45 días asociado a estreptomicina durante las 2-3 primeras semanas

Posteriormente, antibiótico IV dirigido según tinción Gram, cultivo y antibiograma.

NOTA

- Ante toda monoartritis artrocentesis y análisis del líquido sinovial. Primera causa a descartar por gravedad es infecciosa, a pesar de que la causa más frecuente sea la artropatía por microcristales.

BIBLIOGRAFÍA

- Ballina García, F.J. Monoartritis. Manual SER de las enfermedades reumáticas. 2018. 19: 105-109.
- Labandeira Pazos, J; Sobrado Ejo, R. Monoartritis aguda. Libro electrónico de Temas de Urgencias. Servicio Navarro de Salud Osasunbidea. Urgencias HVC.
- Sangüenza Gómez, CI. Análisis del líquido sinovial. Manual SER de enfermedades reumáticas. 2018. 43: 243.